

Integración en TCC, ejercicios y evidencia clínica

QUÉ ES

El mindfulness (atención plena) es la capacidad de prestar atención al momento presente de forma intencional y sin juicio. En el contexto clínico se integra en la TCC de 3ª generación: MBCT (Teasdale), ACT (Hayes) y DBT (Linehan). No es meditación espiritual: es un entrenamiento atencional con base neurocientífica.

BASE TEÓRICA Y EVIDENCIA

Mecanismos de acción

- Reduce la rumiación al anclar la atención en el presente
- Aumenta la regulación emocional y la metacognición
- Disminuye la reactividad automática ante estímulos internos
- Mejora la tolerancia al malestar sin evitación

Evidencia clínica

- MBCT: reduce recaídas en depresión recurrente en 50% (Teasdale)
- ACT: eficaz en ansiedad, dolor crónico y trastornos de conducta
- DBT: componente central para TLP y desregulación emocional
- Eficaz en TDAH, burnout, insomnio y estrés laboral

PRÁCTICA FORMAL VS. PRÁCTICA INFORMAL

Práctica formal

- Tiempo dedicado exclusivamente a practicar
- Escáner corporal (body scan)
- Meditación de la respiración (5-20 minutos)
- Mindfulness de las emociones
- Meditación de bondad amorosa (Loving Kindness)

Práctica informal

- Atención plena en actividades cotidianas
- Comer con plena conciencia
- Caminar conscientemente
- Ducharse prestando atención
- Pausa de 3 minutos (MBCT)

CÓMO INTRODUCIRLO EN SESIÓN

Empezar pequeño

1-3 minutos de atención a la respiración al inicio o cierre de sesión.

Normalizar la distracción

No es "vaciar la mente": es notar los pensamientos y volver. Eso es la práctica.

Práctica entre sesiones

5-10 minutos diarios tienen más impacto que 30 minutos una vez por semana.

Precaución en trauma

El body scan puede activar disociación en pacientes con trauma sin estabilizar.

